

Pr  paration - R  sidanat 2025

Insuffisance surr  nalienn   aigu   - Objectif N  47

1- L'insuffisance surr  nalienn   (IS) aigu   peut se manifester par :

- A) Un tableau pseudo-chirurgical
- B) Des convulsions
- C) Une bradycardie
- D) Des diarrh  es
- E) Une vasopl  gie r  sistante aux amines vasoconstrictrices

R  ponses :

2- L'insuffisance surr  nale aigu   peut se manifester par :

- A) Une d  shydratation
- B) Confusion
- C) Agitation
- D) Des crampes
- E) Une r  tention hydrosod  e

R  ponses :

3- En faveur d'une insuffisance surr  nale lente d'origine p  riph  rique vous retenir :

- A) L'amyotrophie
- B) L'intol  rance au jeun
- C) La d  pigmentation des mamelons
- D) Le tour de taille augment  
- E) L'hypotension

R  ponses :

4- L'insuffisance surr  nalienn   centrale est    l'origine de :

- A) augmentation de la glycog  n   musculaire
- B) diminution de la synth  se des r  cepteurs α et β -adr  nergiques
- C) augmentation de la glycog  n   h  patique
- D) augmentation de l'  rythropo   se
- E) un syndrome de s  cr  tion inappropri   d'ADH

R  ponses :

5- Les signes biologiques en faveur de l'insuffisance corticotrope aigue sont:

- A) L'hypoglyc  mie
- B) L'hyponatr  mie
- C) L'hyperkali  mie
- D) L'hypocalc  mie
- E) Une insuffisance r  nale fonctionnelle

R  ponses :

6- Le bloc enzymatique en 21 hydroxylase est    l'origine d' :

- A) Hypokali  mie
- B) Atrophie surr  nalienn   bilat  rale
- C) Augmentation de 17-hydroxyprogest  rone
- D) Augmentation de production d'androg  nes
- E) Anticorps anti-21 hydroxylase positifs

R  ponses :

7- Les   tiologies d'insuffisance surr  nalienn  , pouvant donner une m  lanodermie, sont :

- A) Bloc enzymatique en 21 hydroxylase
- B) Thrombose surr  nalienn  
- C) Arr  t brutal d'une corticoth  rapie au long cours
- D) Syndrome de Sheehan
- E) Tuberculose surr  nalienn  

R  ponses :

8- Les causes de maladie d'Addison sont:

- A) La tuberculose
- B) Les anticorps anti-21hydroxylase
- C) L'arr  t brutal de la corticoth  rapie au long cours
- D) Radioth  rapie c  r  brale
- E) Le traumatisme abdominal grave

R  ponses :

9- Une insuffisance surr  nalienn   p  riph  rique d'origine g  n  tique chez un individu du sexe f  minin peut   tre en rapport avec:

- A) Mutation du g  ne Prop 1
- B) Une adr  noleucodystrophie
- C) Un bloc en 21 hydroxylase
- D) Mutation du g  ne LHX4
- E) Mutation du g  ne HESX1

R  ponses :

10- L'adr  noleucodystrophie est :

- A) A l'origine d'insuffisance surr  nalienn   potentiellement r  versible
- B) A l'origine d'insuffisance corticotrope familiale
- C) Une maladie g  n  tique r  cessive li  e    l'X
- D) A l'origine de troubles neurologiques
- E) Une accumulation d'acides gras    tr  s longues cha  nes au syst  me nerveux et surr  nales

R  ponses :

11- Le diagnostic d'insuffisance surr  nalienn   d'origine auto-immune est   voqu   en 1  r lieu devant :

- A) Le sexe masculin
- B) L'  ge jeune
- C) L'association    une maladie de Basedow
- D) Aspect des surr  nales hypertrophi  es
- E) Aspect des surr  nales calcifi  es    la TDM

R  ponses :

12- Une ISA peut survenir au cours d'IS chronique lors d'un :

- A) Avortement
- B) Jeune prolong  
- C) Injection en IM de glucocortico  des 3 jours de suite
- D) Vomissements r  p  t  s
- E) Accident grave de la voie publique

R  ponses :

13- Une ISA peut survenir dans le cadre d'IS chronique trait  e en cas de :

- A) Exc  s d'ajout de sel dans l'alimentation
- B) Arr  t d'hydrocortisone
- C) Autom  dication par laxatifs
- D) Diarrh  es
- E) Absc  s dentaire

R  ponses :

14- Les causes de d  compensation aigue d'une insuffisance surr  naliennne connue sont :

- A) Septic  mie
- B) R  gime sans sel strict
- C) Prise de cortico  des
- D) Coronarographie
- E) Anorexie

R  ponses :

15- La d  compensation aigue de maladie d'Addison est caract  ris  e par une:

- A) Insuffisance r  nale aigue
- B) Hyponatr  mie avec natriur  se conserv  e
- C) Hyperkali  mie
- D) hypocalc  mie
- E) Hyperchlor  mie

R  ponses :

16- L'insuffisance surr  naliennne est caract  ris  e par une:

- A) Leucop  nie
- B) hyper  osinophilie mod  r  e
- C) hyperglyc  mie mod  r  e    jeun
- D) lymphop  nie
- E) an  mie microcytaire

R  ponses :

17-Les m  canismes de maladie d'Addison sont:

- A) Insuffisance surr  nalienn   auto-immune
- B) Un surdosage en AVK
- C) Une auto-m  dication par des glucocortico  des par voie cutan  e
- D) Une chirurgie d'ad  n  me surr  nalien s  cr  tant le cortisol
- E) La tuberculose

R  ponses :

18- Une insuffisance surr  nalienn   associ  e    des surr  nales atrophi  es peut   tre observ  e au cours de :

- A) M  tastases surr  naliennes
- B) Apoplexie hypophysaire r  cente
- C) Tuberculose surr  nalienn  
- D) Insuffisance surr  nalienn   auto-immune
- E) Bloc enzymatique en 21 hydroxylase

R  ponses :

19- Les surr  nales peuvent   tre hypertrophi  es au cours de :

- A) La tuberculose
- B) Mutation du g  ne Prop1
- C) Un cancer pulmonaire
- D) Un bloc enzymatique en 21 hydroxylase
- E) Utilisation de k  toconazole

R  ponses :

20- Une IS chez un patient infect   par VIH peut   tre    une atteinte surr  nalienn   par :

- A) La tuberculose
- B) Une corticoth  rapie lors de HTIC
- C) Une infection fongique
- D) Le traitement anti-r  troviral
- E) Une localisation surr  nalienn   de sarcome de Kaposi

R  ponses :

21-En cas d'insuffisance corticotrope, l'exploration    demander est :

- A) Un scanner abdominal
- B) Une   chographie surr  nalienne
- C) Une IRM hypophysaire
- D) Un bilan hormonal hypophysaire complet
- E) Un dosage d'ADH

R  ponses :

22- Au cours de l'insuffisance corticotrope:

- A) La carence en cortisol peut   tre transitoire
- B) Le cortisol peut augmenter apr  s Synacth  ne^{  }
- C) L'ACTH peut   tre normale
- D) L'aldost  rone plasmatique est diminu  e
- E) Le cortisol plasmatique de base peut   tre normal

R  ponses :

23-L'ISA au cours de la maladie d'Addison se distingue d'une IS centrale par :

- A) La m  lanodermie
- B) La s  v  rit   du tableau clinique
- C) Le d  ficit en min  ralocortico  ide possiblement associ  
- D) L'hypokali  mie
- E) Le d  ficit en ACTH

R  ponses :

24-Les traitements pouvant augmenter les besoins en hydrocortisone chez un patient trait   pour insuffisance surr  nalienne sont :

- A) Vitamine D
- B) D  xam  thasone
- C) Ph  nyto  ine
- D) Rifampicine
- E) Barbiturique

R  ponses :

25-Les causes m  dicamenteuses d'insuffisance surr  nienne sont :

- A) K  toconazole
- B) Synacth  ne
- C) ACTH
- D) OP'DDD (mitotane)
- E) Une injection intramusculaire en Dexam  thasone 4mg

R  ponses :

26-Les causes possibles d'une insuffisance surr  nienne p  riph  rique aigu   sont:

- A) Un syndrome des anticorps anti-phospholipides
- B) Apoplexie hypophysaire
- C) Un traumatisme lombaire grave
- D) M  ningococcie
- E) Un accident des anticoagulants

R  ponses :

27-Le bilan   tiologique d'une insuffisance surr  nienne primaire lente comprend:

- A) Un scanner surr  nien
- B) La recherche de BK dans les urines
- C) Un dosage d'ACTH
- D) Une IRM hypophysaire
- E) Le dosage d'aldost  rone

R  ponses :

28-Une insuffisance surr  nienne aigu   :

- A) N  cessite une confirmation par un bilan hormonal
- B) Impose un traitement urgent par h  misuccinate d'hydrocortisone injectable
- C) Impose une augmentation de dose d'hydrocortisone 10 : 5 cp/j
- D) Impose une hospitalisation
- E) Impose un traitement par syncortyl* en IM en cas d'hypopituitarisme

R  ponses :

29-Les conseils    donner    cette patiente pour pr  venir une d  compensation aigue de sa maladie :

- A- Doubler la dose d'hydrocortisone en cas de vomissements r  p  t  s
- B- R  gime sans sel
- C- Doubler la dose d'hydrocortisone lors du jeun du mois de ramadan
- D- Porter la carte d'insuffisance surr  nalienn  
- E- Passage    la voie injectable d'hydrocortisone avant un acte chirurgicale

R  ponses :

30-La confirmation du diagnostic d'insuffisance surr  nalienn   est possible devant :

- A) Un dosage de cortisol plasmatique    8h < 50 ng/ml
- B) Un dosage de la cortisolurie des 24h diminu  
- C) Un dosage des 17 OH progest  rone diminu  
- D) Un dosage de cortisol plasmatique apr  s synacth  ne < 180 ng/ml
- E) Un dosage de l'ACTH augment  

R  ponses :

31-Le test au Synacth  ne 250   g imm  diat :

- A) Peut   tre r  alis   lors d'un   pisode aigu de suspicion d'insuffisance surr  nalienn  
- B) Donnant un pic s  cr  toire de cortisol > 180 ng/ml permet de confirmer une IS
- C) Est le test de r  f  rence de l'atteinte p  riph  rique surr  nalienn  
- D) Explore la s  cr  tion des min  ralo-cortico  des
- E) Peut-  tre normal dans l'insuffisance corticotrope r  cente

R  ponses :

32-Le test d'hypoglyc  mie insulinique :

- A) Est un test de r  f  rence de bloc enzymatique
- B) N  cessite une injection d'insuline rapide
- C) Est indiqu   si forte suspicion d'IS avec test au synacth  ne 250  g normal
- D) Permet d'explorer l'axe somatotrope
- E) Est indiqu   si la cortisol  mie de base est < 50 ng/ml

R  ponses :

33-Les contres indications du test d'hypoglyc  mie insulinique sont :

- A) Infarctus du myocarde
- B) Epilepsie
- C) Sujet   g  
- D) Cortisol  mie > 180 ng/ml apr  s Synacth  ne
- E) Insuffisance surr  nalienn   aigu  

R  ponses :

34-Le traitement par 9  -fludrocortisone peut   tre recommand   au cours de:

- A) Un hypopituitarisme
- B) Un d  ficit en 21 hydroxylase avec syndrome de perte de sel
- C) Une maladie d'Addison
- D) Un syndrome de Sheehan
- E) Un arr  t brutal d'une corticoth  rapie au long cours

R  ponses :

35-En cas de maladie d'Addison, le traitement par hydrocortisone :

- A) Est prescrit    vie
- B) Doit   tre administr   le soir
- C) Peut   tre associ      la fludrocortisone
- D) Est surveill   par le dosage r  gulier de la cortisol  mie
- E) Doit   tre diminu   au cours de la grossesse

R  ponses :

36-Les signes en faveur de l'insuffisance surr  nalienn   par arr  t brutal de corticoth  rapie sont :

- A) Une intol  rance au jeun
- B) Une m  lanodermie
- C) Des palpitations
- D) Un Amaigrissement
- E) Une hypotension orthostatique

R  ponses :

37-Au cours d'un pan-hypopituitarisme complet chez un patiente de 20 ans, le premier axe de la r  gion hypothalamo-hypophysaire    substituer est :

- A) L'axe thyro  trope
- B) La post hypophyse
- C) L'axe somatotrope
- D) L'axe corticotrope
- E) L'axe gonadotrope

R  ponses :

38-Au cours de la maladie d'Addison, le traitement par hydrocortisone :

- A) Est prescrit    vie
- B) Doit   tre administr      50% de dose le soir
- C) Peut   tre associ      la fludrocortisone
- D) Est surveill   par le dosage r  gulier du cortisol plasmatique
- E) Doit   tre diminu   au cours de la grossesse

R  ponses :

39-Les situations    risque d'insuffisance surr  nienne lors d'une prise de cortico  des :

- A) Aspect «cushingo  de»
- B) Administration matinale de cortico  des en dose unique
- C) Dur  e de traitement par cortico  des de plus de 3 mois
- D) Une injection de cortico  des en intra-musculaire 3 jours de suite
- E) Bolus de cortico  des par voie intraveineuse 3 jours de suite

R  ponses :

40-Patiente M est trait  e par prednisone durant plus de 3 mois. La dose actuelle est de 5 mg/j. Un arr  t est pr  conis  . La patiente se plaint d'asth  nie, la conduite    tenir comporte :

- A) Un dosage de cortisol plasmatique    8h    jeun
- B) Un test au synacth  ne 250 µg si cortisol    8h    130 nmol/L
- C) Un test    l'hypoglyc  mie insulinique si cortisol    8h    320 nmol/L
- D) Un dosage de cortisol plasmatique    minuit
- E) Un dosage de cortisol plasmatique    16h

R  ponses :

Cas clinique :

Madame MS,   g  e de 60 ans, hypertendue, consulte pour asth  nie, douleurs abdominales et vomissements   voluant depuis 2 jours.

Elle a consult   un Rhumatologue, 2 ans auparavant, pour poly arthralgies. Elle a   t   mise sous prednisolone 50 mg/j pendant 5 j. La patiente a repris le m  me TT de son propre chef pendant 6 mois et en cas d'oubli parfois des prises le soir. La derni  re prise de cortico  des remonte    10 jours.

A l'examen: poids : 98 Kg (poids ant  rieur: 82 Kg), TA : 10/6 cmHg, pouls : 100 batt/mn,   rythro  se faciale, vergetures pourpres au niveau des 2 flancs.

Bilan : Glyc  mie : 0,6 g/l, ur  e : 13 mmol/l, cr  atinin  mie : 120   mol/l, CRP : 13mg/l, GB : 7770 el/mm³, Na⁺ : 128mmol/l, K⁺ 3,2mmol/l, calc  mie : 2,1 mmol/l.

QCM1- Chez cette patiente, l'insuffisance surr  nali  ne aigu   est   voqu  e devant:

- A- La kali  mie
- B- La calc  mie
- C- Les Globules Blancs
- D- La natr  mie
- E- La glyc  mie

R  ponses :

QCM2- Le diagnostic d'insuffisance surr  nali  ne secondaire    l'arr  t brutal de cortico  des est probable devant :

- A- La dur  e de prise de cortico  de
- B- Le type de cortico  de
- C- Le mode d'administration des cortico  des
- D- La prise de poids
- E- Des signes de syndrome de cushing iatrog  ne

R  ponses :

QCM3- Le cortisol plasmatique = 42 ng/ml. Le diagnostic positif d'insuffisance surr  nalienn   chez cette patiente:

- A-** N  cessite le dosage de l'ACTH
- B-** N  cessite la r  alisation d'un test au synacth  ne
- C-** N  cessite un contr  le de la cortisol  mie    8 h du matin
- D-** N  cessite le dosage de la r  nine et de l'aldost  rone
- E-** Est retenu

R  ponses :